Hohe Anspannung verstehen

Hohe Anspannung kann Aufmerksamkeit, Einordnung und den Zugang zu Handlungsmöglichkeiten vorübergehend verändern. Das funktionale Stressmodell beschreibt Möglichkeiten – kein «Borderline-Gehirn».

HOHE ANSPANNUNG VERÄNDERT VORÜBERGEHEND DEN SPIELRAUM

1

Aufmerksamkeit verteilen

Einzelne Signale können dringlicher wirken, während anderes weniger erreichbar ist.

2

Informationen im Blick behalten

Mehrere Informationen oder Ziele gleichzeitig präsent zu halten, kann unter akutem Stress schwerer sein.

3

Flexibel abwägen

Zwischen Deutungen zu wechseln und eine Situation neu zu bewerten, kann vorübergehend schwerer fallen.

4

Zeit und weniger Reize

Eine Pause, ein ruhigerer Ort oder weniger gleichzeitige Anforderungen können entlasten.

5

Selbst gewählte Strategien

Erlernte Fertigkeiten, Bewegung, Sinnesreize oder andere persönliche Strategien können helfen – aber nicht immer und nicht jeder Person gleich.

6

Unterstützung oder Abstand

Kontakt, praktische Hilfe, professionelle Unterstützung oder Abstand können passend sein. Die betroffene Person und Angehörige dürfen ihre Wünsche und Grenzen benennen; Angehörige müssen keine Beruhigung erreichen.

FUNKTIONAL, NICHT ANATOMISCH

Die geplante Darstellung zeigt veränderliche Zusammenhänge zwischen Situation, Anspannung und Handlungsspielraum. Sie bildet keine Hirnregionen ab, ist kein diagnostisches Modell und erlaubt keine Aussage darüber, wie das Gehirn einer einzelnen Person funktioniert.

VERANTWORTUNG, GRENZEN UND SICHERHEIT BLEIBEN BESTEHEN

Hohe Anspannung kann Verhalten beeinflussen, hebt die Verantwortung für eigenes Verhalten aber nicht auf. Sie erklärt keine Absicht und macht verletzendes Verhalten nicht in Ordnung. Selbstbestimmung, klare Grenzen und Sicherheit bleiben wichtig.

Eigene didaktische Darstellung der Fachstelle Angehörigenarbeit. Fachlicher Bezug: Eigene didaktische Darstellung. Fachliche Bezugspunkte: Shields et al. (2016) zu akutem Stress und Exekutivfunktionen; Degasperi et al. (2021) zur uneinheitlichen fMRT-Evidenz bei BPS; Baranger et al. (2020) zu grossen strukturellen Stichproben. Kein anatomisches oder diagnostisches Modell.

Dieses Blatt ersetzt keine persönliche Beratung oder Behandlung.

Für Angehörige – Fachstelle Angehörigenarbeit, PUK Zürich – Ch. Egger | Entwurf – fachlich-redaktionelle Freigabe ausstehend | Stand: 05.10.2026.